Capítulo 1: Cardiologia Clínica

1.1 Insuficiência cardíaca

1.1.1 Definição e contexto

A insuficiência cardíaca é a síndrome clínica na qual o coração é incapaz de bombear sangue suficiente para as necessidades metabólicas dos tecidos ou o faz à custa de pressões de enchimento elevadas. No caso didático 1.1, o paciente tinha 31 anos, pressão arterial de 171/62 mmHg, frequência cardíaca de 58 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

Ao final da seção 1, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 3 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 1.2 é de 1,4% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

1.1.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dispneia aos esforços, ortopneia, edema de membros inferiores, turgência jugular e terceira bulha. No caso didático 1.2, o paciente tinha 55 anos, pressão arterial de 143/67 mmHg, frequência cardíaca de 66 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 1.3, com sensibilidade de 93% e especificidade de 92%, um teste aplicado a 1927 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Insuficiência cardíaca (seção 1), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

1.1.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em restrição de sódio, diuréticos de alça para congestão e associação de inibidor da ECA, betabloqueador, antagonista mineralocorticoide e inibidor de SGLT2. Na série didática do exercício 1.5, 237 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 8 meses, com 32 reinternações no período. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 1.3, o paciente tinha 79 anos, pressão arterial de 161/78 mmHg, frequência cardíaca de 59 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 1.6 foi de 58 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 8 a 28 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.2 Hipertensão arterial sistêmica

1.2.1 Definição e contexto

A hipertensão arterial sistêmica é definida por valores persistentes de pressão arterial iguais ou superiores a 140/90 mmHg em medidas de consultório. No caso didático 2.1, o paciente tinha 36 anos, pressão arterial de 149/103 mmHg, frequência cardíaca de 75 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

Ao final da seção 2, o aluno deve ser capaz de listar 4 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 8 minutos. No capítulo sobre Hipertensão arterial sistêmica (seção 2), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

1.2.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem cefaleia occipital, epistaxe, retinopatia hipertensiva e hipertrofia ventricular esquerda no eletrocardiograma. No caso didático 2.2, o paciente tinha 47 anos, pressão arterial de 165/98 mmHg, frequência cardíaca de 125 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 2.3, com sensibilidade de 78% e especificidade de 73%, um teste aplicado a 4485 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

1.2.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em mudanças de estilo de vida e início de tiazídico, inibidor da ECA, bloqueador de receptor de angiotensina ou bloqueador de canal de cálcio. Na série didática do exercício 2.5, 91 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 24 meses, com 4 reinternações no período. A prevalência fictícia adotada no exemplo 2.5 é de 4,3% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

No caso didático 2.3, o paciente tinha 66 anos, pressão arterial de 141/100 mmHg, frequência cardíaca de 76 bpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 90 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.3 Síndrome coronariana aguda

1.3.1 Definição e contexto

A síndrome coronariana aguda engloba a angina instável e o infarto agudo do miocárdio com e sem supradesnivelamento do segmento ST. No caso didático 3.1, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 167/61 mmHg, frequência cardíaca de 108 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

Ao final da seção 3, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 9 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 3.2 é de 16,3% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

1.3.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dor torácica opressiva com irradiação para o braço esquerdo, sudorese fria, alterações do segmento ST e elevação de troponina. No caso didático 3.2, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 168/102 mmHg, frequência cardíaca de 77 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 3.3, com sensibilidade de 81% e especificidade de 70%, um teste aplicado a 4064 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Síndrome coronariana aguda (seção 3), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 7 exames laboratoriais de controle.

1.3.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em ácido acetilsalicílico, segundo antiagregante, anticoagulação e reperfusão precoce por angioplastia primária ou fibrinólise. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. Recomenda-se reavaliação clínica em 24 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 3.3, o paciente tinha 76 anos, pressão arterial de 166/58 mmHg, frequência cardíaca de 112 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente. Na série didática do exercício 3.6, 184 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 21 meses, com 18 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.4 Fibrilação atrial

1.4.1 Definição e contexto

A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum, caracterizada por ativação atrial desorganizada e resposta ventricular irregular. No caso didático 4.1, o paciente tinha 83 anos, pressão arterial de 172/102 mmHg, frequência cardíaca de 93 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 4, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 34 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

1.4.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem palpitações, pulso irregular, ausência de onda P e intervalos RR irregulares no eletrocardiograma. No caso didático 4.2, o paciente tinha 51 anos, pressão arterial de 107/83 mmHg, frequência cardíaca de 123 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 4.3, com sensibilidade de 80% e especificidade de 96%, um teste aplicado a 2699 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

1.4.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em controle da frequência ou do ritmo e anticoagulação guiada pelo escore CHA2DS2-VASc. No capítulo sobre Fibrilação atrial (seção 4), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 5 exames laboratoriais de controle. Na série didática do exercício 4.5, 99 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 15 meses, com 56 reinternações no período.

No caso didático 4.3, o paciente tinha 83 anos, pressão arterial de 171/103 mmHg, frequência cardíaca de 106 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 4.6 é de 15,8% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.5 Valvopatias

1.5.1 Definição e contexto

As valvopatias são alterações estruturais ou funcionais das valvas cardíacas que causam estenose, insuficiência ou ambas. No caso didático 5.1, o paciente tinha 34 anos, pressão arterial de 121/102 mmHg, frequência cardíaca de 106 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

Ao final da seção 5, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 5 minutos. O valor de corte usado na questão 5.2 foi de 81 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 3 a 17 unidades.

1.5.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem sopros característicos, dispneia, síncope aos esforços na estenose aórtica e fibrilação atrial na estenose mitral. No caso didático 5.2, o paciente tinha 79 anos, pressão arterial de 162/64 mmHg, frequência cardíaca de 69 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 5.3, com sensibilidade de 70% e especificidade de 70%, um teste aplicado a 4702 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Valvopatias (seção 5), o seguimento ambulatorial inclui 2 consultas no primeiro ano e 3 exames laboratoriais de controle.

1.5.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em acompanhamento ecocardiográfico seriado e correção cirúrgica ou percutânea quando surgem sintomas ou disfunção ventricular. A prevalência fictícia adotada no exemplo 5.5 é de 1,6% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 5.3, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 168/68 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 34 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.6 Endocardite infecciosa

1.6.1 Definição e contexto

A endocardite infecciosa é a infecção do endocárdio, geralmente das valvas, mais frequentemente por Staphylococcus aureus e estreptococos do grupo viridans. No caso didático 6.1, o paciente tinha 80 anos, pressão arterial de 141/91 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

Ao final da seção 6, o aluno deve ser capaz de listar 4 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 8 minutos. Na série didática do exercício 6.2, 177 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 22 meses, com 53 reinternações no período.

1.6.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem febre persistente, sopro novo, petéquias, nódulos de Osler, lesões de Janeway e hemoculturas positivas. No caso didático 6.2, o paciente tinha 48 anos, pressão arterial de 142/72 mmHg, frequência cardíaca de 95 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 6.3, com sensibilidade de 87% e especificidade de 82%, um teste aplicado a 3354 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 44 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

1.6.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em antibioticoterapia endovenosa prolongada guiada por cultura e cirurgia nos casos de insuficiência cardíaca refratária ou abscesso. O valor de corte usado na questão 6.5 foi de 31 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 6 a 10 unidades. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 6.3, o paciente tinha 46 anos, pressão arterial de 145/72 mmHg, frequência cardíaca de 107 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 6.6 é de 25,8% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.7 Miocardiopatias

1.7.1 Definição e contexto

As miocardiopatias são doenças primárias do músculo cardíaco, classificadas em dilatada, hipertrófica, restritiva e arritmogênica. No caso didático 7.1, o paciente tinha 71 anos, pressão arterial de 118/93 mmHg, frequência cardíaca de 58 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 7, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 6 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 7.2 é de 23,6% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

1.7.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem cardiomegalia, arritmias, sopro sistólico que aumenta com a manobra de Valsalva na forma hipertrófica e sinais de insuficiência cardíaca. No caso didático 7.2, o paciente tinha 63 anos, pressão arterial de 167/58 mmHg, frequência cardíaca de 54 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 7.3, com sensibilidade de 95% e especificidade de 85%, um teste aplicado a 141 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 63 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

1.7.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em tratamento da insuficiência cardíaca, avaliação do risco de morte súbita e uso de cardiodesfibrilador implantável quando indicado. Na série didática do exercício 7.5, 280 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 12 meses, com 9 reinternações no período. No capítulo sobre Miocardiopatias (seção 7), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 6 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 7.3, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 119/68 mmHg, frequência cardíaca de 124 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 7.6 foi de 65 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 7 a 25 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

1.8 Doença arterial periférica

1.8.1 Definição e contexto

A doença arterial periférica é a obstrução aterosclerótica das artérias dos membros, principalmente os inferiores. No caso didático 8.1, o paciente tinha 35 anos, pressão arterial de 171/104 mmHg, frequência cardíaca de 102 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

Ao final da seção 8, o aluno deve ser capaz de listar 7 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. O valor de corte usado na questão 8.2 foi de 34 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 2 a 26 unidades.

1.8.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem claudicação intermitente, pulsos diminuídos, pele fria e queda do índice tornozelo-braquial abaixo de 0,9. No caso didático 8.2, o paciente tinha 30 anos, pressão arterial de 164/73 mmHg, frequência cardíaca de 86 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 8.3, com sensibilidade de 77% e especificidade de 90%, um teste aplicado a 4216 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

1.8.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em cessação do tabagismo, exercício supervisionado, estatina, antiagregante e revascularização nos casos de isquemia crítica. Na série didática do exercício 8.5, 271 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 7 meses, com 4 reinternações no período. No capítulo sobre Doença arterial periférica (seção 8), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 8.3, o paciente tinha 70 anos, pressão arterial de 110/93 mmHg, frequência cardíaca de 83 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 8.6 é de 15,9% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

Capítulo 2: Pneumologia

2.1 Asma

2.1.1 Definição e contexto

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas com obstrução variável e reversível ao fluxo de ar. No caso didático 9.1, o paciente tinha 70 anos, pressão arterial de 175/88 mmHg, frequência cardíaca de 127 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

Ao final da seção 9, o aluno deve ser capaz de listar 5 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 4 minutos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

2.1.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem sibilos, tosse noturna, dispneia episódica e variação do pico de fluxo expiratório superior a 20%. No caso didático 9.2, o paciente tinha 42 anos, pressão arterial de 135/102 mmHg, frequência cardíaca de 71 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 9.3, com sensibilidade de 94% e especificidade de 90%, um teste aplicado a 3037 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 45 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

2.1.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em corticoide inalatório como base do tratamento, beta-2 agonista de curta ação para resgate e controle dos fatores desencadeantes. Na série didática do exercício 9.5, 300 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 33 meses, com 38 reinternações no período. O valor de corte usado na questão 9.5 foi de 56 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 4 a 21 unidades.

No caso didático 9.3, o paciente tinha 63 anos, pressão arterial de 110/58 mmHg, frequência cardíaca de 75 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente. No capítulo sobre Asma (seção 9), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.2 Doença pulmonar obstrutiva crônica

2.2.1 Definição e contexto

A doença pulmonar obstrutiva crônica é caracterizada por limitação persistente ao fluxo aéreo, geralmente progressiva e associada ao tabagismo. No caso didático 10.1, o paciente tinha 81 anos, pressão arterial de 106/75 mmHg, frequência cardíaca de 58 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

Ao final da seção 10, o aluno deve ser capaz de listar 7 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 2 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 10.2 é de 15,3% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

2.2.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem tosse crônica, expectoração, dispneia progressiva e relação VEF1/CVF pós-broncodilatador inferior a 0,70. No caso didático 10.2, o paciente tinha 29 anos, pressão arterial de 120/77 mmHg, frequência cardíaca de 116 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 10.3, com sensibilidade de 91% e especificidade de 91%, um teste aplicado a 754 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Doença pulmonar obstrutiva crônica (seção 10), o seguimento ambulatorial inclui 2 consultas no primeiro ano e 4 exames laboratoriais de controle.

2.2.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em cessação do tabagismo, broncodilatadores de longa ação, reabilitação pulmonar, vacinação e oxigenoterapia na hipoxemia crônica. Na série didática do exercício 10.5, 312 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 10 meses, com 60 reinternações no período. Recomenda-se reavaliação clínica em 38 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 10.3, o paciente tinha 42 anos, pressão arterial de 160/91 mmHg, frequência cardíaca de 84 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.3 Pneumonia adquirida na comunidade

2.3.1 Definição e contexto

A pneumonia adquirida na comunidade é a infecção aguda do parênquima pulmonar adquirida fora do ambiente hospitalar, sendo o Streptococcus pneumoniae o agente mais comum. No caso didático 11.1, o paciente tinha 30 anos, pressão arterial de 136/60 mmHg, frequência cardíaca de 89 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 11, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 6 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 11.2 é de 10,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

2.3.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem febre, tosse com expectoração purulenta, crepitações localizadas e consolidação na radiografia de tórax. No caso didático 11.2, o paciente tinha 74 anos, pressão arterial de 113/96 mmHg, frequência cardíaca de 86 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 11.3, com sensibilidade de 94% e especificidade de 81%, um teste aplicado a 2569 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Pneumonia adquirida na comunidade (seção 11), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 10 exames laboratoriais de controle.

2.3.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em estratificação pelo escore CURB-65 e antibioticoterapia empírica com amoxicilina ou associação de beta-lactâmico e macrolídeo nos casos graves. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 11.3, o paciente tinha 32 anos, pressão arterial de 128/99 mmHg, frequência cardíaca de 107 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 15 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.4 Tromboembolismo pulmonar

2.4.1 Definição e contexto

O tromboembolismo pulmonar é a obstrução das artérias pulmonares por êmbolos, em geral originados das veias profundas dos membros inferiores. No caso didático 12.1, o paciente tinha 59 anos, pressão arterial de 126/92 mmHg, frequência cardíaca de 114 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 12, o aluno deve ser capaz de listar 4 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 2 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 26 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

2.4.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dispneia súbita, dor pleurítica, taquicardia, hipoxemia e D-dímero elevado em pacientes com baixa probabilidade pré-teste. No caso didático 12.2, o paciente tinha 84 anos, pressão arterial de 128/80 mmHg, frequência cardíaca de 116 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 12.3, com sensibilidade de 71% e especificidade de 69%, um teste aplicado a 2831 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

2.4.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em anticoagulação imediata, angiotomografia para confirmação e trombólise nos casos de instabilidade hemodinâmica. A prevalência fictícia adotada no exemplo 12.5 é de 8,4% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. No capítulo sobre Tromboembolismo pulmonar (seção 12), o seguimento ambulatorial inclui 8 consultas no primeiro ano e 11 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 12.3, o paciente tinha 53 anos, pressão arterial de 98/67 mmHg, frequência cardíaca de 61 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente. Na série didática do exercício 12.6, 106 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 26 meses, com 38 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.5 Derrame pleural

2.5.1 Definição e contexto

O derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural, classificado em transudato ou exsudato pelos critérios de Light. No caso didático 13.1, o paciente tinha 72 anos, pressão arterial de 152/102 mmHg, frequência cardíaca de 107 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 13, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 4 minutos. No capítulo sobre Derrame pleural (seção 13), o seguimento ambulatorial inclui 5 consultas no primeiro ano e 9 exames laboratoriais de controle.

2.5.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dispneia, macicez à percussão, diminuição do murmúrio vesicular e velamento do seio costofrênico. No caso didático 13.2, o paciente tinha 46 anos, pressão arterial de 144/100 mmHg, frequência cardíaca de 63 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 13.3, com sensibilidade de 90% e especificidade de 87%, um teste aplicado a 2986 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 70 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

2.5.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em toracocentese diagnóstica, tratamento da doença de base e drenagem torácica nos empiemas. A prevalência fictícia adotada no exemplo 13.5 é de 16,4% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. Na série didática do exercício 13.5, 178 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 18 meses, com 3 reinternações no período.

No caso didático 13.3, o paciente tinha 33 anos, pressão arterial de 102/66 mmHg, frequência cardíaca de 114 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.6 Tuberculose pulmonar

2.6.1 Definição e contexto

A tuberculose pulmonar é a infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmitida por aerossóis de pacientes bacilíferos. No caso didático 14.1, o paciente tinha 83 anos, pressão arterial de 165/74 mmHg, frequência cardíaca de 54 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

Ao final da seção 14, o aluno deve ser capaz de listar 9 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 4 minutos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

2.6.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem tosse por mais de três semanas, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cavitação em lobos superiores. No caso didático 14.2, o paciente tinha 74 anos, pressão arterial de 118/102 mmHg, frequência cardíaca de 127 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 14.3, com sensibilidade de 82% e especificidade de 70%, um teste aplicado a 1332 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Tuberculose pulmonar (seção 14), o seguimento ambulatorial inclui 6 consultas no primeiro ano e 8 exames laboratoriais de controle.

2.6.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em esquema RIPE por seis meses, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol nos dois primeiros, além de busca ativa de contatos. Recomenda-se reavaliação clínica em 36 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme. Na série didática do exercício 14.5, 142 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 3 meses, com 26 reinternações no período.

No caso didático 14.3, o paciente tinha 76 anos, pressão arterial de 127/98 mmHg, frequência cardíaca de 124 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 14.6 foi de 57 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 6 a 14 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.7 Síndrome do desconforto respiratório agudo

2.7.1 Definição e contexto

A síndrome do desconforto respiratório agudo é uma lesão pulmonar inflamatória difusa que causa hipoxemia grave e edema não cardiogênico. No caso didático 15.1, o paciente tinha 37 anos, pressão arterial de 132/103 mmHg, frequência cardíaca de 63 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 15, o aluno deve ser capaz de listar 5 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 65 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

2.7.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem hipoxemia refratária, infiltrados bilaterais na radiografia e relação PaO2/FiO2 inferior a 300. No caso didático 15.2, o paciente tinha 55 anos, pressão arterial de 110/92 mmHg, frequência cardíaca de 111 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 15.3, com sensibilidade de 99% e especificidade de 78%, um teste aplicado a 948 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Síndrome do desconforto respiratório agudo (seção 15), o seguimento ambulatorial inclui 8 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

2.7.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em ventilação protetora com volume corrente de 6 mL/kg de peso predito, PEEP adequada e posição prona nos casos graves. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. Na série didática do exercício 15.5, 153 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 29 meses, com 53 reinternações no período.

No caso didático 15.3, o paciente tinha 58 anos, pressão arterial de 152/69 mmHg, frequência cardíaca de 122 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 15.6 foi de 40 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 9 a 14 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

2.8 Apneia obstrutiva do sono

2.8.1 Definição e contexto

A apneia obstrutiva do sono é caracterizada por episódios repetidos de colapso das vias aéreas superiores durante o sono. No caso didático 16.1, o paciente tinha 76 anos, pressão arterial de 137/89 mmHg, frequência cardíaca de 107 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente.

Ao final da seção 16, o aluno deve ser capaz de listar 8 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 9 minutos. Na série didática do exercício 16.2, 295 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 30 meses, com 11 reinternações no período.

2.8.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem ronco, sonolência diurna excessiva, obesidade, circunferência cervical aumentada e índice de apneia-hipopneia igual ou superior a 5 eventos por hora. No caso didático 16.2, o paciente tinha 37 anos, pressão arterial de 118/100 mmHg, frequência cardíaca de 76 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 16.3, com sensibilidade de 97% e especificidade de 62%, um teste aplicado a 1463 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. O valor de corte usado na questão 16.4 foi de 18 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 5 a 28 unidades.

2.8.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em perda de peso, pressão positiva contínua nas vias aéreas e avaliação de dispositivos orais ou de cirurgia em casos selecionados. A prevalência fictícia adotada no exemplo 16.5 é de 4,7% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. No capítulo sobre Apneia obstrutiva do sono (seção 16), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 16.3, o paciente tinha 62 anos, pressão arterial de 153/103 mmHg, frequência cardíaca de 83 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

Capítulo 3: Gastroenterologia e Hepatologia

3.1 Doença do refluxo gastroesofágico

3.1.1 Definição e contexto

A doença do refluxo gastroesofágico resulta do fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para o esôfago, causando sintomas ou lesões. No caso didático 17.1, o paciente tinha 64 anos, pressão arterial de 126/60 mmHg, frequência cardíaca de 115 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente.

Ao final da seção 17, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. O valor de corte usado na questão 17.2 foi de 73 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 7 a 12 unidades.

3.1.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem pirose, regurgitação, tosse crônica e esofagite à endoscopia. No caso didático 17.2, o paciente tinha 55 anos, pressão arterial de 162/88 mmHg, frequência cardíaca de 79 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 17.3, com sensibilidade de 77% e especificidade de 90%, um teste aplicado a 203 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Na série didática do exercício 17.4, 137 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 25 meses, com 32 reinternações no período.

3.1.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em medidas comportamentais e inibidor de bomba de prótons por oito semanas, com endoscopia nos casos com sinais de alarme. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. A prevalência fictícia adotada no exemplo 17.5 é de 15,1% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

No caso didático 17.3, o paciente tinha 51 anos, pressão arterial de 121/58 mmHg, frequência cardíaca de 102 bpm e saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente. No capítulo sobre Doença do refluxo gastroesofágico (seção 17), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 11 exames laboratoriais de controle.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.2 Úlcera péptica

3.2.1 Definição e contexto

A úlcera péptica é uma solução de continuidade da mucosa gástrica ou duodenal, associada principalmente à infecção por Helicobacter pylori e ao uso de anti-inflamatórios. No caso didático 18.1, o paciente tinha 40 anos, pressão arterial de 132/64 mmHg, frequência cardíaca de 95 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

Ao final da seção 18, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. O valor de corte usado na questão 18.2 foi de 41 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 6 a 18 unidades.

3.2.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dor epigástrica que piora com a alimentação na úlcera gástrica e alivia na duodenal, além de hematêmese ou melena nas complicações. No caso didático 18.2, o paciente tinha 71 anos, pressão arterial de 143/92 mmHg, frequência cardíaca de 63 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 18.3, com sensibilidade de 77% e especificidade de 76%, um teste aplicado a 4417 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A prevalência fictícia adotada no exemplo 18.4 é de 19,5% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

3.2.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em erradicação do Helicobacter pylori com terapia tripla, suspensão do anti-inflamatório e inibidor de bomba de prótons. No capítulo sobre Úlcera péptica (seção 18), o seguimento ambulatorial inclui 8 consultas no primeiro ano e 9 exames laboratoriais de controle. Na série didática do exercício 18.5, 162 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 14 meses, com 20 reinternações no período.

No caso didático 18.3, o paciente tinha 31 anos, pressão arterial de 124/89 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.3 Doença de Crohn

3.3.1 Definição e contexto

A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal transmural que pode acometer qualquer segmento do trato digestivo, mais comumente o íleo terminal. No caso didático 19.1, o paciente tinha 65 anos, pressão arterial de 129/59 mmHg, frequência cardíaca de 72 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

Ao final da seção 19, o aluno deve ser capaz de listar 9 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 9 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 21 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

3.3.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem diarreia crônica, dor em fossa ilíaca direita, perda de peso, fístulas e lesões em saltos à colonoscopia. No caso didático 19.2, o paciente tinha 62 anos, pressão arterial de 158/83 mmHg, frequência cardíaca de 121 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 19.3, com sensibilidade de 72% e especificidade de 85%, um teste aplicado a 238 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

3.3.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em corticoide para surtos, imunossupressores e biológicos anti-TNF para manutenção e cirurgia nas estenoses e fístulas. A prevalência fictícia adotada no exemplo 19.5 é de 20,9% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. Na série didática do exercício 19.5, 381 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 9 meses, com 8 reinternações no período.

No caso didático 19.3, o paciente tinha 33 anos, pressão arterial de 153/65 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 19.6 foi de 85 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 9 a 21 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.4 Retocolite ulcerativa

3.4.1 Definição e contexto

A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória restrita à mucosa do cólon, que se inicia no reto e se estende de forma contínua. No caso didático 20.1, o paciente tinha 72 anos, pressão arterial de 175/96 mmHg, frequência cardíaca de 71 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

Ao final da seção 20, o aluno deve ser capaz de listar 9 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 4 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 20.2 é de 4,8% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

3.4.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem diarreia sanguinolenta, urgência evacuatória, tenesmo e perda do padrão vascular na colonoscopia. No caso didático 20.2, o paciente tinha 52 anos, pressão arterial de 152/73 mmHg, frequência cardíaca de 70 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 20.3, com sensibilidade de 70% e especificidade de 76%, um teste aplicado a 1487 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Na série didática do exercício 20.4, 263 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 10 meses, com 45 reinternações no período.

3.4.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em mesalazina para casos leves a moderados, corticoide nos surtos e colectomia na colite grave refratária. No capítulo sobre Retocolite ulcerativa (seção 20), o seguimento ambulatorial inclui 6 consultas no primeiro ano e 5 exames laboratoriais de controle. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 20.3, o paciente tinha 31 anos, pressão arterial de 99/103 mmHg, frequência cardíaca de 62 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 20.6 foi de 57 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 7 a 28 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.5 Cirrose hepática

3.5.1 Definição e contexto

A cirrose hepática é o estágio final da fibrose crônica do fígado, com distorção da arquitetura e formação de nódulos de regeneração. No caso didático 21.1, o paciente tinha 42 anos, pressão arterial de 161/61 mmHg, frequência cardíaca de 68 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

Ao final da seção 21, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 12 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 60 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

3.5.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem icterícia, ascite, aranhas vasculares, esplenomegalia, varizes esofágicas e encefalopatia hepática. No caso didático 21.2, o paciente tinha 51 anos, pressão arterial de 143/79 mmHg, frequência cardíaca de 111 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 21.3, com sensibilidade de 94% e especificidade de 68%, um teste aplicado a 2654 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. O valor de corte usado na questão 21.4 foi de 83 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 3 a 23 unidades.

3.5.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em tratamento da causa, restrição de sódio, diuréticos, betabloqueador não seletivo para prevenção de sangramento e rastreio de carcinoma hepatocelular. Na série didática do exercício 21.5, 211 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 31 meses, com 18 reinternações no período. No capítulo sobre Cirrose hepática (seção 21), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 11 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 21.3, o paciente tinha 30 anos, pressão arterial de 114/72 mmHg, frequência cardíaca de 71 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 21.6 é de 12,5% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.6 Pancreatite aguda

3.6.1 Definição e contexto

A pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas, tendo como causas mais frequentes a litíase biliar e o consumo de álcool. No caso didático 22.1, o paciente tinha 47 anos, pressão arterial de 104/65 mmHg, frequência cardíaca de 96 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

Ao final da seção 22, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 11 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 10 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

3.6.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem dor epigástrica intensa em faixa, náuseas, vômitos e elevação da lipase sérica a mais de três vezes o limite superior. No caso didático 22.2, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 145/62 mmHg, frequência cardíaca de 59 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 22.3, com sensibilidade de 98% e especificidade de 80%, um teste aplicado a 161 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. O valor de corte usado na questão 22.4 foi de 87 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 5 a 19 unidades.

3.6.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em hidratação vigorosa, analgesia, nutrição enteral precoce e colecistectomia na pancreatite biliar. A prevalência fictícia adotada no exemplo 22.5 é de 28,3% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 22.3, o paciente tinha 82 anos, pressão arterial de 136/92 mmHg, frequência cardíaca de 66 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente. No capítulo sobre Pancreatite aguda (seção 22), o seguimento ambulatorial inclui 6 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.7 Hepatite B crônica

3.7.1 Definição e contexto

A hepatite B crônica é a infecção pelo vírus da hepatite B com persistência do antígeno HBsAg por mais de seis meses. No caso didático 23.1, o paciente tinha 41 anos, pressão arterial de 159/60 mmHg, frequência cardíaca de 66 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

Ao final da seção 23, o aluno deve ser capaz de listar 8 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 12 minutos. No capítulo sobre Hepatite B crônica (seção 23), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

3.7.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem quadro assintomático na maioria dos casos, com elevação variável de aminotransferases e positividade do HBsAg e do HBV-DNA. No caso didático 23.2, o paciente tinha 67 anos, pressão arterial de 149/82 mmHg, frequência cardíaca de 104 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 23.3, com sensibilidade de 71% e especificidade de 70%, um teste aplicado a 3501 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Na série didática do exercício 23.4, 221 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 5 meses, com 7 reinternações no período.

3.7.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em tratamento com tenofovir ou entecavir nos casos com replicação e atividade inflamatória, e vacinação dos contatos suscetíveis. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. A prevalência fictícia adotada no exemplo 23.5 é de 25,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

No caso didático 23.3, o paciente tinha 79 anos, pressão arterial de 159/93 mmHg, frequência cardíaca de 80 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 9 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

3.8 Doença celíaca

3.8.1 Definição e contexto

A doença celíaca é uma enteropatia autoimune desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. No caso didático 24.1, o paciente tinha 55 anos, pressão arterial de 119/94 mmHg, frequência cardíaca de 101 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 24, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. No capítulo sobre Doença celíaca (seção 24), o seguimento ambulatorial inclui 8 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

3.8.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem diarreia crônica, distensão abdominal, anemia ferropriva, anticorpos antitransglutaminase positivos e atrofia de vilosidades na biópsia duodenal. No caso didático 24.2, o paciente tinha 53 anos, pressão arterial de 129/60 mmHg, frequência cardíaca de 125 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 24.3, com sensibilidade de 76% e especificidade de 83%, um teste aplicado a 3220 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A prevalência fictícia adotada no exemplo 24.4 é de 25,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

3.8.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em dieta isenta de glúten por toda a vida e correção das deficiências nutricionais. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. Na série didática do exercício 24.5, 52 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 34 meses, com 24 reinternações no período.

No caso didático 24.3, o paciente tinha 84 anos, pressão arterial de 164/94 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 57 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

Capítulo 4: Nefrologia e Eletrólitos

4.1 Lesão renal aguda

4.1.1 Definição e contexto

A lesão renal aguda é a redução abrupta da função renal, definida por elevação da creatinina de pelo menos 0,3 mg/dL em 48 horas ou por oligúria. No caso didático 25.1, o paciente tinha 31 anos, pressão arterial de 105/74 mmHg, frequência cardíaca de 61 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

Ao final da seção 25, o aluno deve ser capaz de listar 8 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 2 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 25.2 é de 13,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

4.1.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem oligúria, elevação de ureia e creatinina, hipercalemia e acidose metabólica. No caso didático 25.2, o paciente tinha 41 anos, pressão arterial de 147/77 mmHg, frequência cardíaca de 128 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 25.3, com sensibilidade de 70% e especificidade de 97%, um teste aplicado a 4247 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 31 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

4.1.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em identificação da causa pré-renal, renal ou pós-renal, correção da volemia, suspensão de nefrotóxicos e diálise nas indicações clássicas. No capítulo sobre Lesão renal aguda (seção 25), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 9 exames laboratoriais de controle. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 25.3, o paciente tinha 33 anos, pressão arterial de 161/74 mmHg, frequência cardíaca de 103 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente. Na série didática do exercício 25.6, 145 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 6 meses, com 34 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.2 Doença renal crônica

4.2.1 Definição e contexto

A doença renal crônica é definida por alteração da estrutura ou da função renal presente por mais de três meses. No caso didático 26.1, o paciente tinha 38 anos, pressão arterial de 117/87 mmHg, frequência cardíaca de 111 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 26, o aluno deve ser capaz de listar 7 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 12 minutos. Na série didática do exercício 26.2, 390 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 34 meses, com 37 reinternações no período.

4.2.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem taxa de filtração glomerular abaixo de 60 mL/min/1,73 m², albuminúria, anemia e hiperparatireoidismo secundário. No caso didático 26.2, o paciente tinha 57 anos, pressão arterial de 149/94 mmHg, frequência cardíaca de 106 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 26.3, com sensibilidade de 71% e especificidade de 96%, um teste aplicado a 3403 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Doença renal crônica (seção 26), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 3 exames laboratoriais de controle.

4.2.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em controle da pressão arterial e da glicemia, inibidor da ECA na albuminúria e preparo para terapia renal substitutiva. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. O valor de corte usado na questão 26.5 foi de 68 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 1 a 15 unidades.

No caso didático 26.3, o paciente tinha 49 anos, pressão arterial de 133/84 mmHg, frequência cardíaca de 57 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 43 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.3 Síndrome nefrótica

4.3.1 Definição e contexto

A síndrome nefrótica é caracterizada por proteinúria maior que 3,5 g em 24 horas, hipoalbuminemia, edema e dislipidemia. No caso didático 27.1, o paciente tinha 54 anos, pressão arterial de 139/103 mmHg, frequência cardíaca de 54 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente.

Ao final da seção 27, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 11 minutos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

4.3.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem edema periorbitário e generalizado, espuma na urina e risco aumentado de trombose venosa. No caso didático 27.2, o paciente tinha 30 anos, pressão arterial de 130/87 mmHg, frequência cardíaca de 84 bpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 27.3, com sensibilidade de 97% e especificidade de 71%, um teste aplicado a 4676 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Recomenda-se reavaliação clínica em 24 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

4.3.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em corticoide nos casos de lesão mínima, biópsia renal em adultos, diurético e inibidor da ECA para reduzir a proteinúria. Na série didática do exercício 27.5, 100 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 24 meses, com 3 reinternações no período. O valor de corte usado na questão 27.5 foi de 80 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 2 a 27 unidades.

No caso didático 27.3, o paciente tinha 84 anos, pressão arterial de 118/101 mmHg, frequência cardíaca de 88 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 27.6 é de 13,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.4 Síndrome nefrítica

4.4.1 Definição e contexto

A síndrome nefrítica é um quadro de inflamação glomerular com hematúria, hipertensão, edema e redução da taxa de filtração. No caso didático 28.1, o paciente tinha 71 anos, pressão arterial de 151/70 mmHg, frequência cardíaca de 81 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

Ao final da seção 28, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 9 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 50 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

4.4.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem urina cor de coca-cola, hipertensão, hemácias dismórficas, cilindros hemáticos e consumo de complemento na glomerulonefrite pós-estreptocócica. No caso didático 28.2, o paciente tinha 65 anos, pressão arterial de 172/100 mmHg, frequência cardíaca de 86 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 28.3, com sensibilidade de 77% e especificidade de 76%, um teste aplicado a 1162 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. Na série didática do exercício 28.4, 193 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 12 meses, com 30 reinternações no período.

4.4.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em restrição de sal e água, diurético, controle da pressão e tratamento específico conforme a etiologia. O valor de corte usado na questão 28.5 foi de 75 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 4 a 23 unidades. No capítulo sobre Síndrome nefrítica (seção 28), o seguimento ambulatorial inclui 2 consultas no primeiro ano e 11 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 28.3, o paciente tinha 54 anos, pressão arterial de 173/82 mmHg, frequência cardíaca de 108 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 28.6 é de 5,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.5 Hiponatremia

4.5.1 Definição e contexto

A hiponatremia é definida por sódio sérico inferior a 135 mEq/L e é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum em pacientes internados. No caso didático 29.1, o paciente tinha 49 anos, pressão arterial de 102/69 mmHg, frequência cardíaca de 56 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 29, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 3 minutos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

4.5.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem náuseas, cefaleia, confusão mental e convulsões quando a queda é grave ou rápida. No caso didático 29.2, o paciente tinha 64 anos, pressão arterial de 144/85 mmHg, frequência cardíaca de 86 bpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 29.3, com sensibilidade de 71% e especificidade de 64%, um teste aplicado a 2120 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Hiponatremia (seção 29), o seguimento ambulatorial inclui 5 consultas no primeiro ano e 5 exames laboratoriais de controle.

4.5.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em avaliação da osmolaridade e do volume extracelular, restrição hídrica na SIADH e solução salina hipertônica nos casos sintomáticos graves, com correção de no máximo 8 mEq/L em 24 horas. Recomenda-se reavaliação clínica em 47 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 29.3, o paciente tinha 72 anos, pressão arterial de 164/77 mmHg, frequência cardíaca de 63 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente. Na série didática do exercício 29.6, 146 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 32 meses, com 41 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.6 Hipercalemia

4.6.1 Definição e contexto

A hipercalemia é a elevação do potássio sérico acima de 5,5 mEq/L, frequentemente causada por insuficiência renal e medicamentos. No caso didático 30.1, o paciente tinha 56 anos, pressão arterial de 126/62 mmHg, frequência cardíaca de 87 bpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente.

Ao final da seção 30, o aluno deve ser capaz de listar 6 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 10 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 75 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

4.6.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem fraqueza muscular, ondas T apiculadas, alargamento do QRS e arritmias no eletrocardiograma. No caso didático 30.2, o paciente tinha 81 anos, pressão arterial de 114/77 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 30.3, com sensibilidade de 90% e especificidade de 86%, um teste aplicado a 1753 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Hipercalemia (seção 30), o seguimento ambulatorial inclui 2 consultas no primeiro ano e 7 exames laboratoriais de controle.

4.6.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em gluconato de cálcio para proteção da membrana, insulina com glicose, beta-2 agonista inalatório e resinas ou diálise para remoção. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. Na série didática do exercício 30.5, 107 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 18 meses, com 14 reinternações no período.

No caso didático 30.3, o paciente tinha 73 anos, pressão arterial de 104/83 mmHg, frequência cardíaca de 54 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente. A prevalência fictícia adotada no exemplo 30.6 é de 4,6% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.7 Nefrolitíase

4.7.1 Definição e contexto

A nefrolitíase é a formação de cálculos no sistema urinário, sendo os de oxalato de cálcio os mais frequentes. No caso didático 31.1, o paciente tinha 28 anos, pressão arterial de 113/81 mmHg, frequência cardíaca de 102 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 31, o aluno deve ser capaz de listar 4 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 3 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 21 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

4.7.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem cólica renal intensa com irradiação para a região inguinal, hematúria e náuseas. No caso didático 31.2, o paciente tinha 84 anos, pressão arterial de 119/82 mmHg, frequência cardíaca de 104 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 31.3, com sensibilidade de 81% e especificidade de 78%, um teste aplicado a 960 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A prevalência fictícia adotada no exemplo 31.4 é de 7,6% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

4.7.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em analgesia com anti-inflamatório, hidratação, tamsulosina para cálculos distais menores que 10 mm e litotripsia ou ureteroscopia nos casos complicados. Na série didática do exercício 31.5, 346 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 31 meses, com 4 reinternações no período. No capítulo sobre Nefrolitíase (seção 31), o seguimento ambulatorial inclui 2 consultas no primeiro ano e 7 exames laboratoriais de controle.

No caso didático 31.3, o paciente tinha 31 anos, pressão arterial de 109/92 mmHg, frequência cardíaca de 103 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 31.6 foi de 27 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 6 a 14 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

4.8 Infecção do trato urinário

4.8.1 Definição e contexto

A infecção do trato urinário é a invasão microbiana de qualquer segmento das vias urinárias, tendo a Escherichia coli como agente mais frequente. No caso didático 32.1, o paciente tinha 63 anos, pressão arterial de 155/63 mmHg, frequência cardíaca de 66 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 32, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 8 minutos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

4.8.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem disúria, polaciúria, urgência miccional, febre e dor lombar na pielonefrite, com piúria e bacteriúria no exame de urina. No caso didático 32.2, o paciente tinha 45 anos, pressão arterial de 135/104 mmHg, frequência cardíaca de 111 bpm e saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 32.3, com sensibilidade de 75% e especificidade de 96%, um teste aplicado a 3533 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Infecção do trato urinário (seção 32), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 6 exames laboratoriais de controle.

4.8.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em antibioticoterapia dirigida por urocultura, como nitrofurantoína na cistite não complicada, e hidratação. Recomenda-se reavaliação clínica em 40 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme. A prevalência fictícia adotada no exemplo 32.5 é de 4,4% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

No caso didático 32.3, o paciente tinha 43 anos, pressão arterial de 152/81 mmHg, frequência cardíaca de 89 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente. Na série didática do exercício 32.6, 268 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 33 meses, com 22 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

Capítulo 5: Endocrinologia e Metabologia

5.1 Diabetes mellitus tipo 2

5.1.1 Definição e contexto

O diabetes mellitus tipo 2 é um distúrbio metabólico caracterizado por resistência à insulina e deficiência relativa de secreção pelas células beta. No caso didático 33.1, o paciente tinha 75 anos, pressão arterial de 101/77 mmHg, frequência cardíaca de 101 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 33, o aluno deve ser capaz de listar 9 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 33.2 é de 7,1% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

5.1.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem poliúria, polidipsia, perda de peso, glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg/dL e hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5%. No caso didático 33.2, o paciente tinha 37 anos, pressão arterial de 128/88 mmHg, frequência cardíaca de 103 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 33.3, com sensibilidade de 89% e especificidade de 89%, um teste aplicado a 4721 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Diabetes mellitus tipo 2 (seção 33), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 10 exames laboratoriais de controle.

5.1.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em mudança de estilo de vida, metformina como primeira linha, inibidor de SGLT2 ou agonista de GLP-1 nos pacientes com doença cardiovascular e rastreio de complicações. Na série didática do exercício 33.5, 279 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 29 meses, com 12 reinternações no período. O valor de corte usado na questão 33.5 foi de 16 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 7 a 14 unidades.

No caso didático 33.3, o paciente tinha 46 anos, pressão arterial de 101/72 mmHg, frequência cardíaca de 95 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 26 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.2 Diabetes mellitus tipo 1

5.2.1 Definição e contexto

O diabetes mellitus tipo 1 resulta da destruição autoimune das células beta pancreáticas, com deficiência absoluta de insulina. No caso didático 34.1, o paciente tinha 32 anos, pressão arterial de 173/93 mmHg, frequência cardíaca de 77 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 34, o aluno deve ser capaz de listar 5 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 5 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 34.2 é de 21,9% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

5.2.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem início agudo com poliúria, polidipsia, emagrecimento, cetoacidose e anticorpos anti-GAD positivos. No caso didático 34.2, o paciente tinha 70 anos, pressão arterial de 129/100 mmHg, frequência cardíaca de 67 bpm e saturação de oxigênio de 88% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 34.3, com sensibilidade de 82% e especificidade de 71%, um teste aplicado a 3010 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Diabetes mellitus tipo 1 (seção 34), o seguimento ambulatorial inclui 6 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

5.2.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em insulinoterapia basal-bolus, contagem de carboidratos, monitorização da glicemia e tratamento da cetoacidose com insulina e hidratação. Na série didática do exercício 34.5, 121 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 12 meses, com 54 reinternações no período. Recomenda-se reavaliação clínica em 8 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 34.3, o paciente tinha 41 anos, pressão arterial de 107/104 mmHg, frequência cardíaca de 75 bpm e saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 34.6 foi de 11 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 1 a 25 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.3 Hipotireoidismo

5.3.1 Definição e contexto

O hipotireoidismo é a deficiência de hormônios tireoidianos, sendo a tireoidite de Hashimoto a causa mais comum em áreas com iodo suficiente. No caso didático 35.1, o paciente tinha 52 anos, pressão arterial de 174/62 mmHg, frequência cardíaca de 81 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

Ao final da seção 35, o aluno deve ser capaz de listar 7 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. No capítulo sobre Hipotireoidismo (seção 35), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

5.3.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, pele seca, bradicardia e TSH elevado com T4 livre baixo. No caso didático 35.2, o paciente tinha 42 anos, pressão arterial de 156/74 mmHg, frequência cardíaca de 104 bpm e saturação de oxigênio de 98% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 35.3, com sensibilidade de 71% e especificidade de 82%, um teste aplicado a 2730 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

5.3.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em reposição de levotiroxina em jejum, com ajuste da dose pelo TSH a cada seis a oito semanas. Na série didática do exercício 35.5, 140 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 17 meses, com 32 reinternações no período. Recomenda-se reavaliação clínica em 29 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 35.3, o paciente tinha 83 anos, pressão arterial de 105/94 mmHg, frequência cardíaca de 98 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 35.6 foi de 41 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 2 a 28 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.4 Hipertireoidismo

5.4.1 Definição e contexto

O hipertireoidismo é o excesso de hormônios tireoidianos circulantes, e a doença de Graves é a sua causa mais frequente. No caso didático 36.1, o paciente tinha 64 anos, pressão arterial de 152/70 mmHg, frequência cardíaca de 106 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

Ao final da seção 36, o aluno deve ser capaz de listar 7 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 6 minutos. Recomenda-se reavaliação clínica em 7 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

5.4.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem perda de peso, tremor, taquicardia, intolerância ao calor, bócio difuso e oftalmopatia, com TSH suprimido. No caso didático 36.2, o paciente tinha 76 anos, pressão arterial de 99/86 mmHg, frequência cardíaca de 66 bpm e saturação de oxigênio de 95% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 36.3, com sensibilidade de 89% e especificidade de 87%, um teste aplicado a 517 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Hipertireoidismo (seção 36), o seguimento ambulatorial inclui 8 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

5.4.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em betabloqueador para os sintomas, metimazol por 12 a 18 meses e iodo radioativo ou tireoidectomia nas recidivas. A prevalência fictícia adotada no exemplo 36.5 é de 6,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 36.3, o paciente tinha 56 anos, pressão arterial de 167/80 mmHg, frequência cardíaca de 57 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. Na série didática do exercício 36.6, 400 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 26 meses, com 20 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.5 Síndrome de Cushing

5.5.1 Definição e contexto

A síndrome de Cushing resulta da exposição prolongada ao excesso de glicocorticoides, sendo a causa mais comum o uso exógeno de corticoides. No caso didático 37.1, o paciente tinha 60 anos, pressão arterial de 152/82 mmHg, frequência cardíaca de 77 bpm e saturação de oxigênio de 91% em ar ambiente.

Ao final da seção 37, o aluno deve ser capaz de listar 9 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 3 minutos. No capítulo sobre Síndrome de Cushing (seção 37), o seguimento ambulatorial inclui 4 consultas no primeiro ano e 12 exames laboratoriais de controle.

5.5.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem obesidade central, face em lua cheia, estrias violáceas, hipertensão, hiperglicemia e fraqueza proximal. No caso didático 37.2, o paciente tinha 42 anos, pressão arterial de 154/73 mmHg, frequência cardíaca de 95 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 37.3, com sensibilidade de 80% e especificidade de 90%, um teste aplicado a 4052 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. A prevalência fictícia adotada no exemplo 37.4 é de 22,9% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

5.5.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em confirmação com cortisol livre urinário, cortisol salivar noturno ou supressão com dexametasona, seguida de investigação etiológica e tratamento cirúrgico do tumor. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 37.3, o paciente tinha 44 anos, pressão arterial de 159/72 mmHg, frequência cardíaca de 76 bpm e saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente. O valor de corte usado na questão 37.6 foi de 88 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 9 a 27 unidades.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.6 Insuficiência adrenal

5.6.1 Definição e contexto

A insuficiência adrenal é a produção insuficiente de cortisol, primária na doença de Addison ou secundária à supressão do eixo hipotálamo-hipófise. No caso didático 38.1, o paciente tinha 43 anos, pressão arterial de 140/83 mmHg, frequência cardíaca de 124 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

Ao final da seção 38, o aluno deve ser capaz de listar 5 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 12 minutos. A prevalência fictícia adotada no exemplo 38.2 é de 15,0% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos.

5.6.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem fadiga, hipotensão, hiperpigmentação cutânea na forma primária, hiponatremia e hipercalemia. No caso didático 38.2, o paciente tinha 65 anos, pressão arterial de 152/59 mmHg, frequência cardíaca de 94 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 38.3, com sensibilidade de 91% e especificidade de 73%, um teste aplicado a 1433 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Insuficiência adrenal (seção 38), o seguimento ambulatorial inclui 3 consultas no primeiro ano e 11 exames laboratoriais de controle.

5.6.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em reposição de hidrocortisona, acréscimo de fludrocortisona na forma primária e doses de estresse durante doenças agudas. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis. Recomenda-se reavaliação clínica em 61 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

No caso didático 38.3, o paciente tinha 57 anos, pressão arterial de 146/79 mmHg, frequência cardíaca de 82 bpm e saturação de oxigênio de 92% em ar ambiente. Na série didática do exercício 38.6, 292 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 22 meses, com 49 reinternações no período.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.7 Hiperparatireoidismo primário

5.7.1 Definição e contexto

O hiperparatireoidismo primário é a secreção autônoma e excessiva de paratormônio, geralmente por adenoma de uma única paratireoide. No caso didático 39.1, o paciente tinha 29 anos, pressão arterial de 117/73 mmHg, frequência cardíaca de 97 bpm e saturação de oxigênio de 99% em ar ambiente.

Ao final da seção 39, o aluno deve ser capaz de listar 5 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 7 minutos. Na série didática do exercício 39.2, 197 pacientes foram acompanhados por uma mediana de 12 meses, com 36 reinternações no período.

5.7.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem hipercalcemia, nefrolitíase, osteoporose, dor óssea, constipação e paratormônio elevado ou inapropriadamente normal. No caso didático 39.2, o paciente tinha 29 anos, pressão arterial de 110/75 mmHg, frequência cardíaca de 107 bpm e saturação de oxigênio de 96% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 39.3, com sensibilidade de 81% e especificidade de 96%, um teste aplicado a 3978 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. No capítulo sobre Hiperparatireoidismo primário (seção 39), o seguimento ambulatorial inclui 7 consultas no primeiro ano e 3 exames laboratoriais de controle.

5.7.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em paratireoidectomia nos pacientes sintomáticos ou com complicações e hidratação nos casos de hipercalcemia grave. A prevalência fictícia adotada no exemplo 39.5 é de 29,5% da população estudada, apenas para o cálculo de valores preditivos. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 39.3, o paciente tinha 28 anos, pressão arterial de 140/97 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 68 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição

5.8 Obesidade

5.8.1 Definição e contexto

A obesidade é definida por índice de massa corporal igual ou superior a 30 kg/m² e está associada a maior risco cardiovascular e metabólico. No caso didático 40.1, o paciente tinha 47 anos, pressão arterial de 161/61 mmHg, frequência cardíaca de 89 bpm e saturação de oxigênio de 93% em ar ambiente.

Ao final da seção 40, o aluno deve ser capaz de listar 3 critérios diagnósticos e justificar a escolha do tratamento em 5 minutos. No capítulo sobre Obesidade (seção 40), o seguimento ambulatorial inclui 5 consultas no primeiro ano e 2 exames laboratoriais de controle.

5.8.2 Achados e diagnóstico

Os achados mais frequentes incluem aumento da circunferência abdominal, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática e resistência à insulina. No caso didático 40.2, o paciente tinha 40 anos, pressão arterial de 159/85 mmHg, frequência cardíaca de 104 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente.

No exemplo de cálculo 40.3, com sensibilidade de 94% e especificidade de 92%, um teste aplicado a 742 pacientes gera falsos positivos e falsos negativos que podem mudar a conduta. O valor de corte usado na questão 40.4 foi de 29 unidades, e o intervalo de referência do laboratório foi de 1 a 24 unidades.

5.8.3 Conduta e seguimento

A conduta inicial consiste em mudança do estilo de vida, farmacoterapia com agonistas de GLP-1 em casos selecionados e cirurgia bariátrica para IMC acima de 40 kg/m² ou acima de 35 kg/m² com comorbidades. A revisão da lista de medicamentos a cada consulta e a educação do paciente sobre sinais de alarme reduzem atrasos no atendimento e eventos adversos evitáveis.

No caso didático 40.3, o paciente tinha 46 anos, pressão arterial de 144/80 mmHg, frequência cardíaca de 108 bpm e saturação de oxigênio de 90% em ar ambiente. Recomenda-se reavaliação clínica em 32 dias, com registro de peso, sinais vitais e adesão ao tratamento, e retorno imediato diante de sinais de alarme.

Cópia licenciada para uso individual — proibida a redistribuição